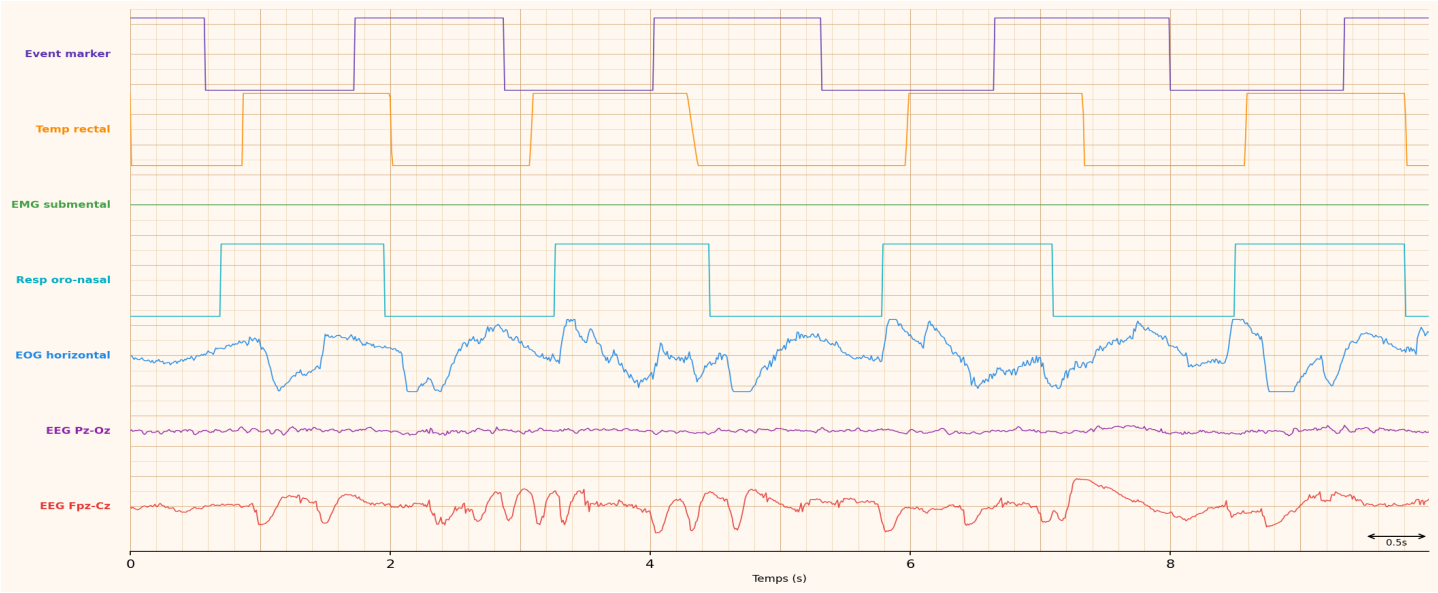
MediVision Kit — Rapport EEG Complet

Patient : e6124362-72f8-4ff7-8f4d-837b0cf4d153 | Âge : — | Sexe : — | Date : 2026-05-08 | Indication : Bilan neurologique

25 mm/s • 10 µV/mm • 40 Hz | Généré : 2026-05-08T15:10:23



DIAGNOSTIC PRINCIPAL

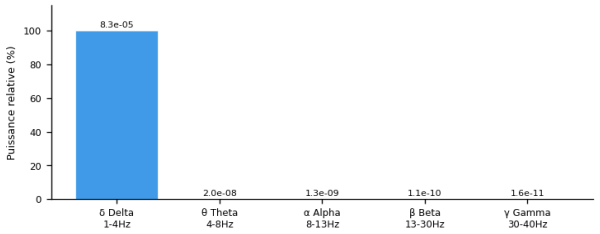
Activité épileptiforme

CIM-11 : 8A61.0

Confiance	16.8%
Canaux	7
Fréquence	100.0 Hz
Durée	79499.99 s
Mode	onnx

VALIDATION AUTO

Bandes spectrales



Diagnostics différentiels

Épilepsie focale CIM-11: 8A61.0 Décharges focales unilatérales

État de mal épileptique CIM-11: 8A62 Crises > 5 min

Rapport généré automatiquement par MediVision Kit. Ne remplace pas l'avis d'un neurologue qualifié.

PRESCRIPTION MÉDICALE — Compte rendu EEG

Patient : e6124362-72f8-4ff7-8f4d-837b0cf4d153 | Âge : — | Sexe : — | Date : 2026-05-08 | Indication : Bilan neurologique | Réf : OMS Liste Médicaments Essentiels 23e éd.

Ordonnance à valider et signer par un médecin habilité

1re intention	2e intention	3e intention
Carbamazépine	**Lamotrigine**	**Lévétiracétam**
Tégrétol	Lamictal	Keppra
Antiépileptique — bloqueur canaux Na■	*Antiépileptique — bloqueur Na■/Ca²■*	*Antiépileptique — modulateur SV2A*
Posologie : 200 mg 2×/jour → 400–800 mg/jour per os	**Posologie :** 25 mg/jour × 2 semaines → 100–200 mg/jour	**Posologie :** 500 mg 2×/jour → 1000–3000 mg/jour
Durée : Long terme — réévaluation annuelle	**Durée :** Long terme — titration lente obligatoire	**Durée :** Long terme, bonne tolérance
Indication : Épilepsie focale — crises partielles	**Indication :** Épilepsie focale + généralisée, Lennox-Gastaut	**Indication :** Épilepsie focale + généralisée, status epilepticus IV
Contre-ind. : BAV, Porphyrie, Hypersensibilité carbamazépine	**Contre-ind. :** Hypersensibilité lamotrigine, Introduire lentement	**Contre-ind. :** Insuffisance rénale sévère (adapter dose)
Surveillance : NFS, bilan hépatique, natrémie à 1 mois	**Surveillance :** Éruption cutanée (SJS), bilan hépatique	**Surveillance :** Comportement (irritabilité), NFS, créatinine

Prescripteur / Médecin validant **Date et cachet**

BILAN BIOLOGIQUE — Compte rendu EEG

Patient : e6124362-72f8-4ff7-8f4d-837b0cf4d153 | Âge : — | Sexe : — | Date : 2026-05-08 | Indication : Bilan neurologique | Réf : SFBC / OMS / LOINC

STAT — Immédiat	URGENT — < 4h	ROUTINE
Glycémie capillaire LOINC 2345-7 Hypoglycémie — cause crise épileptique *Norme : 0,7–1,1 g/L*	**IRM cérébrale + séquence FLAIR** LOINC 36643-5 Lésion structurelle — épilepsie focale symptomatique *Norme : Absence de lésion*	**Dosage antiépileptiques** LOINC 3432-2 Contrôle taux thérapeutique *Norme : Selon molécule*
Ionogramme sanguin LOINC 24326-1 Hyponatrémie / dyskaliémie — seuil épileptogène *Norme : Na 135–145 — K 3,5–5,0 mmol/L*	**EEG de sommeil prolongé** LOINC 18107-6 Confirmation activité épileptiforme intercritique *Norme : Absence de décharges*	**NFS + bilan hépatique** LOINC 2276-4 Tolérance traitement antiépileptique *Norme : Valeurs normales laboratoire*

Prescripteur / Médecin validant **Date et cachet**

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES — Analyse automatique

Patient : e6124362-72f8-4ff7-8f4d-837b0cf4d153 | Âge : — | Sexe : — | Date : 2026-05-08 | Indication : Bilan neurologique | Réf : ANSM / OMS / Base interactions neurologie

MAJEURE — **Carbamazépine + Lamotrigine**

Induction enzymatique — réduction taux lamotrigine de 40–50%

→ **Adapter posologie lamotrigine — dosage plasmatique obligatoire**

MODÉRÉE — **Lévétiracétam + Carbamazépine**

Potentialisation effets indésirables SNC (somnolence, vertiges)

→ **Surveillance neurologique — réduire dose si intolérance**

Prescripteur / Médecin validant **Date et cachet**